

Patient lombalgique: quel examen d'imagerie choisir?

Dre CATHY MELONG PIANTA TALENG^a et Pr STÉPHANE GENEVAY^a

Rev Med Suisse 2022; 18: 487-92 | DOI : 10.53738/REVMED.2022.18.773.487

Les lombalgies sont un véritable problème de santé publique, avec un impact physique et psychosocial important. L'utilisation inappropriée de l'imagerie fait partie des principaux facteurs qui participent aux coûts engendrés par ces pathologies. De plus, il existe des indices pour penser que la réalisation d'un examen d'imagerie et les éléments contenus dans le rapport qui l'accompagne sont des facteurs de risque de chronicité. Cet article aborde les principales situations cliniques auxquelles les cliniciens sont confrontés et résume les recommandations de bonnes pratiques pour chacune d'elles.

Which imaging in patients with low back pain?

Low back pain is a major public health problem, with a significant physical and psychosocial impact. Inappropriate use of diagnostic imaging is one of the main factors contributing to the costs of these conditions. In addition, there is evidence to suggest that imaging and the accompanying report are risk factors for chronicity. This article reviews the main clinical situations that clinicians face and summarizes the good clinical practice recommendations for each of them.

INTRODUCTION

La lombalgie est un symptôme extrêmement fréquent, qui se définit par une douleur rachidienne siégeant entre la 12^e côte et le pli fessier, pouvant parfois s'accompagner de douleurs dans les membres inférieurs à caractère neurogène.¹ C'est la première cause d'invalidité au monde, en particulier dans les pays à hauts revenus.² On estime que la prévalence globale mondiale de la lombalgie est de 540 millions de personnes, représentant ainsi le principal problème de santé ayant besoin des services de réadaptation.³ En Suisse, elle fait partie des 5 motifs de consultation les plus fréquents en médecine de premier recours⁴ et représente de très loin la première cause de perte de capacité fonctionnelle. Les estimations disponibles en matière de coût direct des lombalgies remontent à près de 15 ans et étaient de 2,6 milliards d'euros, représentant alors 6,1% des dépenses annuelles de santé ou 1,6 à 2,3% de notre PIB.⁵ Dans la grande majorité des cas, une source nociceptive ne peut être identifiée et on parle dans ce cas de lombalgie commune. Ce n'est que dans 10 à 15% des cas qu'une cause significative peut être identifiée sur les examens radiologiques et on parle alors soit de lombalgies spécifiques, dont l'identification tient parfois de l'urgence médicale,¹ soit de lombalgie associée à une radiculalgie lorsqu'il y a une

atteinte du système nerveux périphérique. D'un point de vue épidémiologique, il est encore d'usage de distinguer les lombalgies aiguës (jusqu'à 6 semaines), subaiguës (de 6 semaines à 3 mois) et chroniques (plus de 3 mois).⁴ En réalité les études récentes indiquent que moins de 20% des patients consultant pour une lombalgie aiguë vont observer une guérison totale en quelques jours ou semaines, 10% vont souffrir d'une douleur persistante hautement invalidante et la majorité va présenter des fluctuations ou des épisodes récidivants plus ou moins importants durant les mois suivants.

La lombalgie est donc un problème de santé publique qui ne peut s'appréhender qu'en considérant les patients dans leur globalité physique, psychologique et sociale. En effet, en cas de chronicité, les limitations fonctionnelles physiques s'accompagnent de détresse émotionnelle et de répercussions sociales, en particulier sur la capacité professionnelle, entraînant une importante diminution de la qualité de vie et une forte pression sur le système de santé en raison des coûts qui en découlent.⁶ Trois articles séminaux, publiés en 2018 dans *Lancet*, attirent l'attention sur la possibilité de réduire ces coûts faramineux par un meilleur respect des recommandations (guidelines) et pointent en particulier la mauvaise utilisation des examens d'imagerie. Le but de cet article est d'aider le clinicien à faire les bons choix concernant le type d'imagerie à effectuer en cas de lombalgie lorsque c'est nécessaire,⁷ mais aussi à s'abstenir dans la plupart des cas.

DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE GÉNÉRALE

L'anamnèse approfondie est un élément clé dans le triage et la prise en charge des patients souffrant de lombalgie. Il est important de déterminer la durée des symptômes, de faire la distinction entre le caractère mécanique ou inflammatoire de la douleur, de rechercher des éléments évoquant un processus tumoral, une infection, un traumatisme ou des signes neurologiques car ces éléments occupent une place centrale dans la stratégie diagnostique.⁸

Sur le plan clinique, il est important de rechercher des signes locaux, tels que les troubles statiques rachidiens (par exemple, scoliose), les contractures musculaires locales et les limitations des mobilités (qui signalent la présence d'un syndrome lombo-vertébral), cependant aucun de ces signes ou symptômes ne permet d'identifier les structures anatomiques à l'origine de la nociception.⁷ En cas d'irradiation douloureuse dans le membre inférieur, un examen neurologique ciblé est indispensable. Enfin, l'examen clinique permettra aussi d'identifier des pathologies viscérales ou coxofémorales qui peuvent parfois signer une lombalgie.

^aService de rhumatologie, Département de médecine, Hôpitaux universitaires de Genève, 1211 Genève 14
cathy.melongpiantha@hcuge.ch | stephane.genevay@hcuge.ch

INFECTION ET CANCER

L'incidence des infections rachidiennes augmente avec l'âge. Le plus souvent il s'agit de spondylodiscite. La majorité des infections est due à une propagation hématogène des bactéries soit en raison d'une infection à distance, soit après un geste local (infiltration ou chirurgie) ou encore chez les patients utilisant des drogues intraveineuses.⁹ Les principaux signes d'appel sont mentionnés dans le **tableau 1**. Ces éléments étant peu sensibles et peu spécifiques, c'est leur présence concomitante qui doit alerter le clinicien. On veillera donc à rester attentif et à les reconstruire régulièrement. Il est important chez tout patient se présentant avec des lombalgies de rechercher un antécédent de cancer, l'os étant un site de prédilection pour les métastases, en particulier des cancers de poumon, sein, prostate, thyroïde et rein,¹⁰ et ce d'autant plus que les métastases rachidiennes sont peu, voire pas hyperalgiques. Parmi les tumeurs primaires, le myélome est de loin le plus fréquent.

Choix de l'imagerie

Dans ces deux situations, il est recommandé de choisir en première intention l'imagerie par IRM lombaire car elle est la modalité radiologique la plus sensible pour le diagnostic d'une métastase ou d'une infection vertébrale. Des séquences après injections de produit de contraste (IRM injectée) peuvent être utiles si l'on suspecte une métastase ou une infection épidurale ou intraspinale. Bien que meilleur pour apprécier l'os, le CT-scan lombaire est plus irradiant et surtout moins sensible que l'IRM au début de l'affection. On ne l'utilisera en première intention qu'en présence de contre-indications à l'IRM.⁷ Lors d'une forte suspicion clinique, il

peut parfois être nécessaire de répéter l'examen après quelques semaines ou mois, des examens faussement négatifs étant possibles au début de l'affection.

FRACTURE VERTÉBRALE

Les fractures vertébrales peuvent être dues à un traumatisme direct sur le rachis ou à une fragilité osseuse dans un contexte d'ostéoporose. Les premières sont facilement suspectées à l'anamnèse.

Les fractures ostéoporotiques surviennent généralement chez une personne âgée lors de petits traumatismes tels que des chutes mineures, port de charges lourdes ou activités en porte-à-faux. En fonction de l'âge, le degré de suspicion doit donc être élevé. Il est important de rechercher également la notion de prise de corticostéroïdes au long cours. Les fractures par tassement sont les plus courantes des fractures ostéoporotiques et se situent le plus souvent au niveau de la colonne vertébrale médiane (T7-T8) et de la jonction thoracolumbaire (T12-L1).¹¹ Les fractures ostéoporotiques qui se produisent de façon insidieuse au fil du temps sont la plupart du temps asymptomatiques, en revanche les épisodes aigus de tassement du corps vertébral sont associés à la douleur.

Choix de l'imagerie

En cas de traumatisme à haute vitesse, c'est le CT-scan qui est proposé en première intention. Il est plus facile d'accès, plus rapide et permet de contrôler l'intégralité du squelette axial. En raison de sa sensibilité limitée, un complément par IRM est parfois nécessaire à la recherche de lésion ligamentaire pouvant influencer la prise en charge.

La fracture vertébrale est l'une des seules indications dans les douleurs lombaires où la radiographie standard est recommandée en première intention. Il est important de réaliser des incidences de face et de profil. Le principal désavantage de la radiographie lombaire est l'exposition des gonades. Le Collège américain de radiologie recommande cependant, chez tous patients avec haut risque de fracture vertébrale, de demander d'emblée un CT-scan. Parfois, une IRM peut être envisagée chez les patients avec traumatisme vertébral, elle permettra d'évaluer la stabilité ligamentaire et la présence d'hémorragie dans les espaces épiduraux.⁷

SPONDYLARTHRITE AXIALE

Selon la classification actuelle, les spondylarthrites peuvent avoir une forme axiale (AxSpA) et/ou périphérique. Nous n'abordons ici que la première. Sa prévalence est estimée entre 0,2 et 1,2 % de la population, elle débute souvent chez le sujet jeune avec un pic durant la troisième décennie. Son début insidieux la rend plus difficile à reconnaître et il n'est pas rare que le diagnostic ne soit posé qu'après plusieurs années, ce qui est très dommageable pour le patient à l'heure où plusieurs biothérapies sont disponibles et efficaces. On estime à 5 % sa prévalence parmi les patients lombalgiques chroniques consultant en médecine de premier recours. Depuis que la forme non radiologique est reconnue (atteinte

TABLEAU 1 Signaux d'alarmes dans les lombalgies

Le tableau indique les hypothèses diagnostiques et l'imagerie de choix.^{7,21,22}

Signaux d'alerte (red flags)	Affections sous-jacentes potentielles	Types d'imagerie
• Antécédent de cancer • Perte de poids inexpliquée • Immunosuppression • Infection urinaire • Utilisation de drogues intraveineuses • Utilisation prolongée de corticostéroïdes	Cancer ou infection	IRM lombaire
• Histoire de traumatisme important • Chute mineure ou port de charge lourde chez une personne potentiellement ostéoporotique ou âgée • Utilisation prolongée de corticostéroïdes	Fracture vertébrale	• CT-scan pour les fractures à haute énergie • Radiographie standard face et profil pour les fractures ostéoporotiques
• Apparition aiguë de rétention urinaire ou d'incontinence par regorgement • Incontinence fécale • Anesthésie de la selle • Faiblesse motrice significative ou progressive des membres inférieurs	Syndrome de la queue-de-cheval, atteinte neurologique motrice importante ou progressive	IRM lombaire
• Tableau clinique suggestif	Spondylarthrite axiale	IRM des sacro-iliaques

radiologique des sacro-iliaques visibles à l'IRM mais pas à la radiographie), l'épidémiologie a bien changé et l'on ne retrouve plus cette prédominance masculine que l'on a dans la spondylarthrite ankylosante (ou maladie de Bechterew). On constate, actuellement, une fréquence similaire entre les femmes et les hommes et un handicap fonctionnel qui est identique dans les deux formes (radiographique ou non radiographique). L'atteinte prédomine sur les sacro-iliaques plutôt que sur le rachis lombaire mais cette différence topographique ne permet pas au clinicien de faire la différence. Les douleurs des patients avec AxSpA ont plus volontiers des caractéristiques inflammatoires (prédominant en deuxième partie de nuit, obligent à bouger pour les faire diminuer, présence d'une mise en route matinale d'au moins 30 minutes), mais cela n'est ni très sensible ni très spécifique. Les tests cliniques des sacro-iliaques n'ont pas non plus une bonne performance. On veillera donc à rester attentif chez toutes personnes souffrant de lombalgies chroniques avec un début avant la quarantaine, d'autant plus si l'on observe une bonne réponse initiale aux AINS. Comme le montre le **tableau 2**, il est crucial chez ces patients de rechercher les autres signes de maladie pour établir une probabilité prétest et guider la réalisation ou non des investigations complémentaires.¹² En cas de doute, il sera utile de référer le patient à un rhumatologue.

Choix de l'imagerie

Lorsqu'une AxSpA est suspectée, on se dirigera d'emblée vers une IRM des sacro-iliaques. Bien que l'on puisse retrouver parfois des éléments suggestifs lors de la réalisation d'une IRM lombaire, ceux-ci sont peu sensibles et peu spécifiques et cet examen n'est donc pas recommandé dans cette indica-

tion.⁷ La radiographie n'a donc plus sa place pour poser ce diagnostic.

Il est très important de souligner que la présence d'œdème des sacro-iliaques à l'IRM ne suffit pas à poser le diagnostic d'AxSpA. C'est une image qui peut même être très fréquente dans le post-partum ou chez certains groupes de sportifs. L'étendue des lésions, leur localisation à l'intérieur même des sacro-iliaques et d'autres signes radiologiques associés sont très importants pour orienter le diagnostic. Au bout du compte, comme dans tout syndrome, c'est un ensemble de signes et de symptômes qui permet au clinicien de retenir ou non le diagnostic, d'où l'importance d'une expertise spécialisée.

LOMBALGIES ASSOCIÉES À UNE RADICULALGIE

La prévalence des lomboradiculalgies en médecine de premier recours varie énormément selon les études et les populations étudiées. Elles représentent environ 10 % des lombalgies, avec une prévalence similaire entre hommes et femmes. Il existe trois tableaux cliniques avec des signes et des symptômes qui vont parfois varier en fonction du niveau lésionnel. Il est important de faire cliniquement la différence entre un syndrome radiculaire dû à une hernie discale, à un canal lombaire étroit (CLE) ou à un syndrome de la queue-de-cheval.¹³ Les hernies discales et les rétrécissements canauxaux étant très répandus dans la population asymptomatique, seuls une anamnèse et un examen clinique bien conduits permettent de suspecter ces affections et de déterminer l'utilité et l'urgence éventuelle à réaliser une imagerie.

Syndrome radiculaire sur hernie discale

La hernie discale est un déplacement localisé de matériel discal au-delà des limites de l'espace intervertébral. Elle peut être responsable d'une compression et d'une inflammation d'une ou plus rarement de deux racines nerveuses se traduisant par un syndrome radiculaire. Les études faites sur des modèles animaux confortent l'expérience clinique qui indique que l'inflammation joue un rôle plus important que la compression dans l'apparition des symptômes. Ainsi, nombre de hernies discales vont rester totalement asymptomatiques. Lorsqu'elle est enflammée, la racine nerveuse provoque essentiellement des radiculalgies.¹⁴ La lombalgie est très inconstante et son évolution est peu en lien avec celle de la radiculalgie, peu importe que le traitement de celle-ci soit conservateur ou chirurgical.

La clinique des syndromes radiculaires varie selon la racine nerveuse qui est touchée (**tableau 3**).^{15,16} Le plus souvent ce sont les racines L5 et S1. L'atteinte de L3 et L4 semble plus fréquente chez les personnes au-delà de 50 ans. Les caractéristiques cliniques sont détaillées dans le **tableau 4**.

Ces caractéristiques cliniques neurologiques sont en général assez typiques en cas de hernie discale. En revanche, dans le cas d'un rétrécissement foraminaux sur trouble dégénératif, le tableau clinique est souvent incomplet et donc plus difficile à distinguer d'une lombalgie commune avec irradiation non radiculaires.

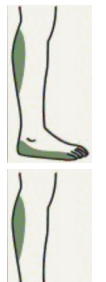
TABLEAU 2 Diagnostic de spondylarthrite axiale

Le tableau liste les éléments participant au diagnostic de spondylarthrite axiale avec leur poids respectif. À partir de la prévalence dans une population donnée, la multiplication des rapports de vraisemblance (RV) correspondant aux éléments présents chez un patient donné permet de connaître la probabilité qu'il ait la maladie. Si l'on postule une prévalence de 5% (cf. texte), un score de 200 correspond à une probabilité de 95%, et un score à 2000 à une probabilité de 99% d'avoir une spondylarthrite. Ainsi, dans une consultation de généraliste, un patient de 35 ans avec des lombalgies depuis plus de 3 mois ayant une bonne réponse à un AINS (RV: 5,1), un père avec une spondylarthrite (RV: 6,4) et un antécédent d'uvéite antérieure (RV: 7,3), aura un RV total de 238 (5,1*6,4*7,3) et une probabilité de 92% d'avoir une spondylarthrite. HLA: Human Leukocyte Antigen.

Caractéristiques ¹⁷	RV
Douleur lombaire inflammatoire	3,1
Douleur des enthèses	3,4
Arthrite périphérique	4,8
Dactylites	4,5
Uvéites antérieures aiguës	7,3
Histoire familiale de spondylarthrite	6,4
Bonne réponse aux anti-inflammatoires	5,1
Syndrome inflammatoire biologique	2,5
HLA-27	9,0
Signes de sacro-iliite à l'IRM	20,0
Sacro-iliite grade 3 à la radiographie	20,0

TABLEAU 3**Éléments caractéristiques d'une radiculopathie**

Le tableau indique les caractéristiques en fonction de la racine nerveuse concernée.

Racine	Douleur	Trouble sensitif	Déficit moteur	Réflexe
L4			Extension du quadriceps Dépistage: difficultés à l'accroupissement et à se relever d'une chaise	Rotulien
L5			Dorsiflexion du pied et du gros orteil Dépistage: marche sur les talons impossible	Aucun réflexe fiable
S1			Flexion plantaire du pied Dépistage: difficulté à marcher sur la pointe du pied	Achilléen

(Adapté de réf. 16).

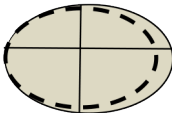
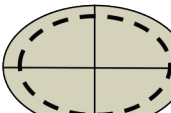
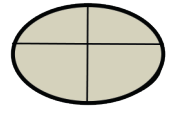
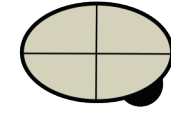
Choix de l'imagerie

Depuis 2001, il existe un consensus sur la définition de la hernie discale qui la différencie explicitement d'un bombement discal circonferentiel (**tableau 5**).¹⁷ Cette différence, qui n'est pas toujours très explicite sur les comptes rendus radiologiques, est pourtant très importante puisque c'est bien la hernie discale et non pas le bombement circonferentiel qui est à l'origine d'un syndrome radiculaire.

Lorsque le clinicien est face à un tableau clinique caractéristique, il n'a pas besoin d'imagerie pour confirmer le diagnostic. L'indication dépend, dans un premier temps, de la présence d'un déficit moteur important ou progressif, avec des répercussions fonctionnelles, qui doit faire discuter d'une attitude chirurgicale dans les 48 heures. C'est l'IRM lombaire qui est l'examen de choix en raison de sa capacité à apprécier la perméabilité du canal rachidien.

Les lombalgies aiguës avec radiculopathie sur hernie discale sans signaux d'alerte ne nécessitent pas la réalisation d'imagerie, l'évolution clinique est souvent spontanément favorable dans

TABLEAU 5**Définition radiologique de la hernie discale**

		Déborder supérieur à 180° du pourtour discal Pas associé à un syndrome radiculaire
Bombement discal asymétrique	Bombement discal symétrique	
		Déborder inférieur à 180° du pourtour discal Associé à un syndrome radiculaire
Hernie discale à base large	Hernie discale focale	

(Adapté de réf. 17).

TABLEAU 4**Hernie discale versus canal lombaire étroit**

Comparaison entre les radiculalgies dues à une hernie discale et celles dues à un canal lombaire étroit.

Caractéristiques	Syndrome radiculaire	Claudication neurogène
Aspect radiologique	Hernie discale	Canal lombaire rétréci
Âge	À tout âge	> 60 ans
Trajet dans les membres inférieurs	Unilatérale monoradiculaire	Bilatéral, fesses et membres inférieurs, flou, non radiculaire
Type de douleur	Au début, caractéristiques nociceptives progressive-ment neuropathiques	Associe des sensations de fatigue et d'engourdissement, la douleur n'est pas forcément prédominante
Marche	Augmente souvent dès les premiers pas	Déclenchement des symptômes après un temps de marche parfois long
Position assise	Augmentation de la radiculalgie (surtout L5 et S1)	Soulagement rapide
Autres caractéristiques cliniques	-	Disparaît en se penchant en avant, moins forte en montée (rachis lombaire en délordose)
Signe irritatif (reproduction des symptômes dans le ou les membres inférieurs)	Lasègue < 60° (L5-S1) ou Test de traction fémorale (Lasègue inversé) (L3-L4)	Test d'extension de 30 secondes
Signes déficitaires	Diminution de la force musculaire, de la sensibilité et des réflexes en fonction de la racine affectée	Déficits moteurs rarement présents Signes de polyneuropathie

les 2 à 3 mois. L'imagerie est en revanche nécessaire avant de recourir à une infiltration, qui peut être envisagée après quelques semaines d'évolution défavorable malgré une bonne antalgie, ou pour entamer un processus de décision partagée autour d'une possible intervention chirurgicale, en général autour du 2^e ou 3^e mois. Le CT-scan est nettement moins sensible; en cas de doute lors de contre-indication à l'IRM, on utilisera la myélographie.⁷

Claudication neurogène due à un canal lombaire étroit

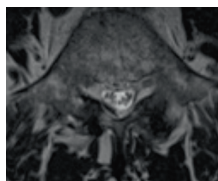
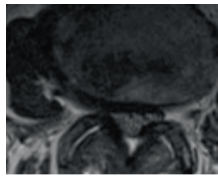
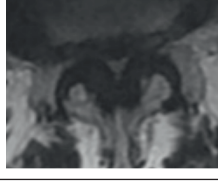
La claudication neurogène est le symptôme cardinal rencontré lors d'un canal lombaire étroit, qui est dans la réalité rarement constitutionnellement étroit mais bien plus souvent rétréci par des troubles dégénératifs. C'est une cause fréquente de symptômes dans les membres inférieurs chez la personne de plus de 60 ans.¹⁸ En raison d'une physiopathologie différente du syndrome radiculaire, plus en lien avec une insuffisance vasculaire des *vasa nervorum* qu'avec une inflammation, le tableau clinique est très différent (tableau 4). Cela explique d'ailleurs également la faible, voire l'absence, d'efficacité des infiltrations de cortisone. C'est une affection chronique d'évolution plutôt lente, avec des phases d'aggravation souvent transitoires, qui ne nécessite quasiment jamais une intervention chirurgicale en urgence.

Choix de l'imagerie

Il n'y a aucun impératif à réaliser une imagerie lorsque la symptomatologie est typique et qu'un traitement conservateur de première intention est requis. Ce n'est qu'en cas d'échec des traitements de première ligne ou lors d'hésitations diagnostiques qu'une imagerie sera réalisée. Une fois de plus, même si le CT-scan est la technique de choix pour analyser la structure osseuse, c'est bien l'IRM lombaire qui est l'examen de choix en raison de sa capacité à bien analyser la situation intracanaulaire.⁷ Plus que le diamètre du canal, voire du sac dural, c'est bien le rapport entre le diamètre de ce dernier et son contenu qui est le plus important. L'utilisation de la classification proposée par Schizas et coll. est aussi intuitive que pratique pour le clinicien et se fait sur l'analyse des coupes axiales en séquence T2 permettant une très bonne distinction entre les racines nerveuses en noir et le liquide céphalorachidien en blanc. Il est tout à fait possible de simplifier la proposition originelle en ne gardant que les 4 stades principaux: A) plages de LCR bien visibles au sein du sac dural; B) racines individualisables malgré l'absence de plage de LCR; C) les racines ne sont plus individualisables mais il reste de la graisse épidurale (aussi en blanc); D) il n'y a plus ni de LCR ni de graisse épidurale dans le canal (tableau 6).¹⁹

Syndrome de la queue-de-cheval

Urgence extrême, le syndrome de la queue-de-cheval est une manifestation rare des lombalgies avec radiculaire. Il se manifeste par un déficit neurologique de progression souvent rapide qui résulte d'une compression de toutes les racines de la queue-de-cheval, en particulier, celles qui composent le plexus sacré. En plus des radiculagies, les signes cliniques caractéristiques sont donc une anesthésie en selle, des pertes urinaires par régurgitations (souvent la période de rétention n'est pas reconnue) et des pertes de selles par béance sphinctérienne.¹³

TABLEAU 6		Classification IRM du canal lombaire étroit
Stades	Description	Exemples
A Faible	Plage de LCR bien visible autour des racines nerveuses	
B Modéré	Absence de plages de LCR visibles Racines nerveuses encore identifiables dans le sac dural	
C Modéré à sévère	Absence de plages de LCR visibles Racines non identifiables dans le sac dural Graisse épidurale présente	
D Sévère	Absence de plages de LCR visibles Racines non identifiables dans le sac dural Graisse épidurale absente	

(Adapté de réf. 19).

Choix de l'imagerie

Il s'agit d'une des rares indications rachidiennes à effectuer une IRM en extrême urgence, une décompression dans les 12 à 24 heures étant une condition importante pour favoriser la récupération.

LOMBALGIE COMMUNE AVEC OU SANS IRRADIATION

En l'absence des éléments précédemment mentionnés, c'est le diagnostic de lombalgie commune qui est retenu, qu'il y ait ou non une irradiation dans les membres inférieurs. Toutes les recommandations s'accordent à dire qu'il n'y a aucune indication à effectuer une IRM lombaire dans les 3 premiers mois de symptôme. En effet aucune des images les plus souvent rapportées sur les comptes rendus (discopathies, arthrose, fissure discale et même hernie discale), par ailleurs très fréquentes dans la population asymptomatique, ne permet d'orienter le traitement ou de prédire l'évolution clinique.²⁰

Ne pas tenir compte de ces recommandations participe de diverses façons à l'augmentation des coûts de la santé. En effet, en plus du coût direct des examens, il a été montré que la réalisation d'une IRM chez ces patients augmente la prescription et la consommation d'opiacés ainsi que le recours à la chirurgie sans aucun bénéfice clinique. Enfin, la lecture du rapport radiologique entraîne une augmentation du catastrophisme tant chez les médecins non spécialistes que chez les

patients. Loin de rassurer patients et médecins, la réalisation d'une IRM dans cette condition participe directement à augmenter le risque de chronicité. La tâche essentielle du médecin est donc de développer une relation thérapeutique de qualité lui permettant de rassurer son patient sans recourir à une imagerie. Si une imagerie devait néanmoins être réalisée, il est indispensable de procéder à une éducation préventive du patient pour tenter d'en diminuer les conséquences délétères.⁸

CONCLUSION

Les recommandations actuelles insistent sur le fait qu'il est primordial de limiter la réalisation de l'imagerie chez les patients avec lombalgie aiguë en l'absence d'un faisceau concordant d'éléments qui proviennent de l'anamnèse et de l'examen clinique. Le respect de ces règles devrait non

seulement entraîner une diminution conséquente des coûts, mais surtout améliorer le devenir de ces patients.

Conflit d'intérêts: Les auteurs n'ont déclaré aucun conflit d'intérêts en relation avec cet article.

IMPLICATIONS PRATIQUES

- Une imagerie ne devrait être réalisée qu'en présence d'un faisceau d'éléments concordant en faveur d'une lombalgie spécifique ou d'une atteinte neurologique
- Une anamnèse et un examen clinique bien conduits sont au cœur de la démarche pour choisir l'examen approprié
- Hormis son coût, la réalisation d'une imagerie est un facteur de risque de chronicité en cas de lombalgie commune. Une attitude préventive est donc indispensable

1 Balagué F, Mannion AF, Pellisé F, Cedraschi C. Non-Specific Low Back Pain. *Lancet* 2012;379:482-91.
 2 Murray CJL, Lopez AD. Measuring the Global Burden of Disease. *N Engl J Med* 2013;369:448-57.
 3 Cieza A, et al. Global estimates of the Need for Rehabilitation Based on the Global Burden of Disease Study 2019: A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *Lancet* 2020;396:2006-17.
 4 Wermelinger F, Villiger PM. Lombalgies : quand faut-il passer à l'imagerie ? *Forum Med Suisse* 2010;10:161-5.
 5 Wieser S, et al. Cost of Low Back Pain in Switzerland in 2005. *Eur J Heal Econ* 2011;12:455-67.
 6 Maniadakis N, Gray A. The Economic Burden of Back Pain in the UK. *Pain* 2000;84:95-103.
 7 **Patel ND, et al. ACR Appropriateness Criteria Low Back Pain. *J Am Coll Radiol*

2016;13:1069-78.
 8 Chou R, Fu R, Carrino JA, Deyo RA. Imaging Strategies for Low-Back Pain: Systematic Review and Meta-Analysis. *Lancet* 2009;373:463-72.
 9 Nolla JM, et al. Spontaneous Pyogenic Vertebral Osteomyelitis in Nondrug Users. *Semin. Arthritis Rheum* 2002;31:271-8.
 10 Deyo RA, Diehl AK. Cancer as a Cause of Back Pain. *J Gen Intern Med* 1988;3:230-8.
 11 Genant HK, et al. Interim Report and Recommendations of the World Health Organization Task-Force for Osteoporosis. *Osteoporos Int* 1999;10:259-64.
 12 *Van Der Linden S, Valkenburg H, Cats A. The Risk of Developing Ankylosing Spondylitis in HLA-B27 Positive Individuals: a Family and Population Study. *Rheumatol (United Kingdom)* 1983;22:18-9.
 13 Tarulli AW, Raynor EM. Lumbosacral

Radiculopathy. *Neurol Clin* 2007;25:387-405.
 14 Jarvik JG, et al. Rapid Magnetic Resonance Imaging vs Radiographs for Patients with Low Back Pain: A Randomized Controlled Trial. *J Am Med Assoc* 2003;289:2810-8.
 15 **Genevay S, et al. Clinical Classification Criteria for Neurogenic Claudication Caused by Lumbar Spinal Stenosis. The N-CLASS criteria. *Spine J* 2018;18:941-7.
 16 Bigos SJ, Richard Bowyer RO, Richard Braen G. Acute Low Back Problems in Adults, AHCPR Guideline No. 14. *J Man Manip Ther* 1996;4:99-111.
 17 *Fardon DF, et al. Lumbar Disc Nomenclature: Version 2.0: Recommendations of the Combined Task Forces of the North American Spine Society, the American Society of Spine Radiology, and the American Society of Neuroradiology. *Spine (Phila. Pa. 1976)* 2014;39:E1448-65.
 18 Magras I, Athanasiou A, Magra V.

Lumbar Spinal Stenosis. *Spine Surg. A Case-Based Approach* 2019;77-80. DOI:10.1007/978-3-319-98875-7_11.
 19 *Schizas C, et al. Qualitative Grading of Severity of Lumbar Spinal Stenosis Based on the Morphology of the Dural Sac on Magnetic Resonance Images. *Spine (Phila. Pa. 1976)* 2010;35:1919-24.
 20 *Jarvik JG, Deyo R. Diagnostic Evaluation of Low Back Pain with Emphasis on Imaging. *Ann Intern Med* 2002;137:586-97. DOI: 10.7326/0003-4819-137-7-200210010-00010.21
 Spechbach H. Lombalgies aiguës : prise en charge. *Lombalgie aiguë* 2017;1-12.
 22 *Mazzola Eusebio O, Motamed S. Indications à l'imagerie dans la lombalgie chez l'adulte. *Rev Med Suisse* 2013;9:1732-6.

* à lire
 ** à lire absolument